



NOMBRE DEL ESTUDIANTE 4to SEMESTRE 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: NEFROSTOMÍA

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

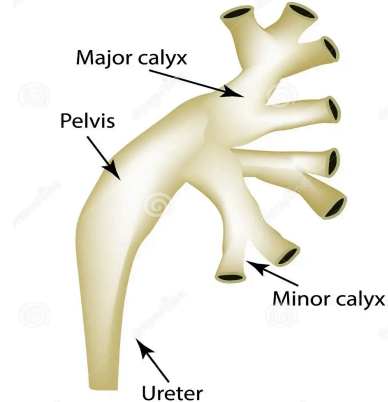
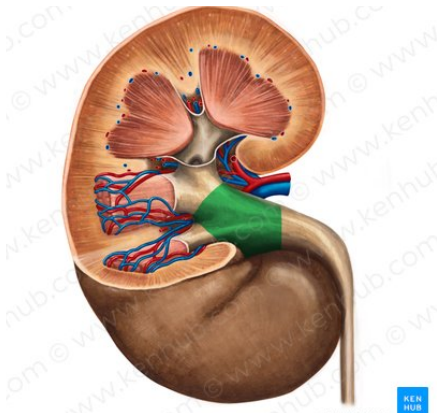
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

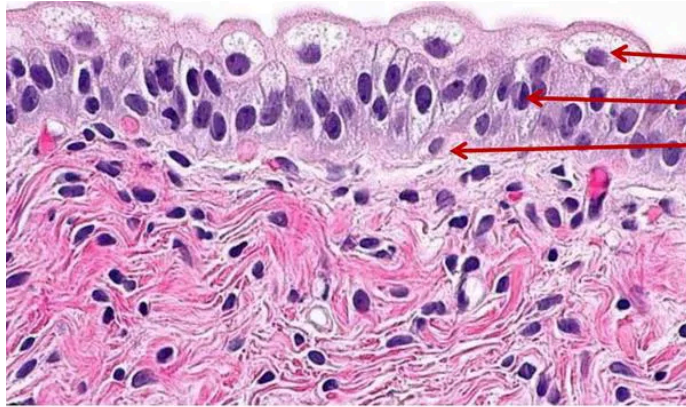
Procedimiento para drenar la orina desde el riñón mediante un catéter a través de la piel

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



La pelvis renal es una estructura anatómica del sistema urinario situada en el hilio del riñón, tiene forma de un embudo, con una amplia base que recibe la orina de los cálices mayores y una punta estrecha que se continúa con el uréter. Está compuesta por: cáliz mayor, cáliz menor y uréter.

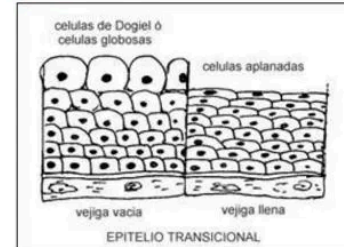


EPITELIO:

Capa superficial

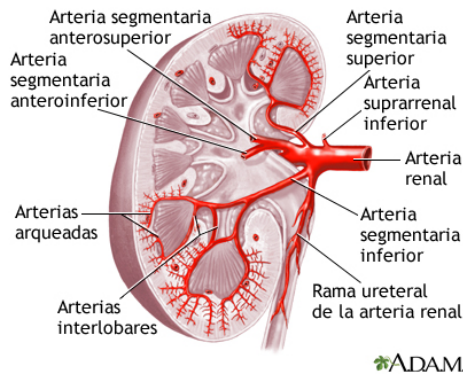
Capa celular intermedia

Capa celular basal



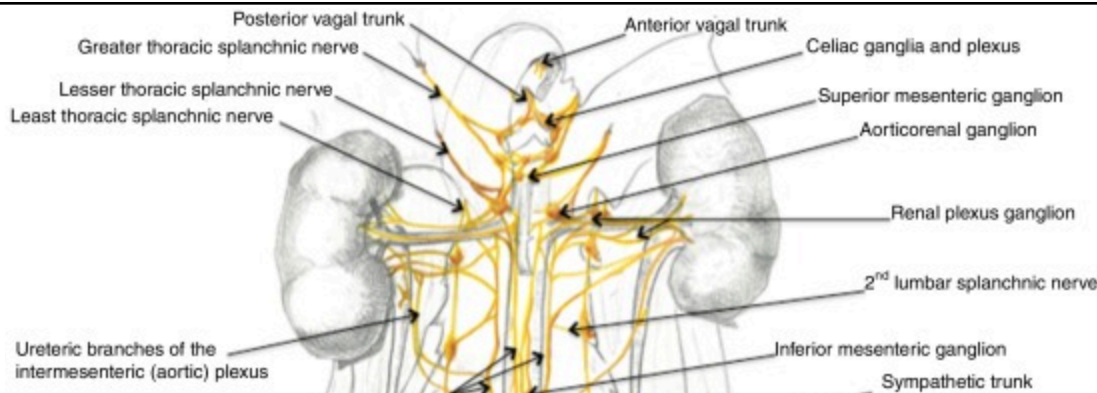
Estructuralmente está constituida por una mucosa, una túnica muscular lisa, dispuesta en una capa interna circular que ayuda en el movimiento de la orina hacia el uréter por medio de contracciones peristálticas y una capa externa longitudinal, y una adventicia. La pelvis renal está revestida por un epitelio de transición, llamado **UOTELIO**, que es flexible y resistente a la orina.

IRRIGACIÓN



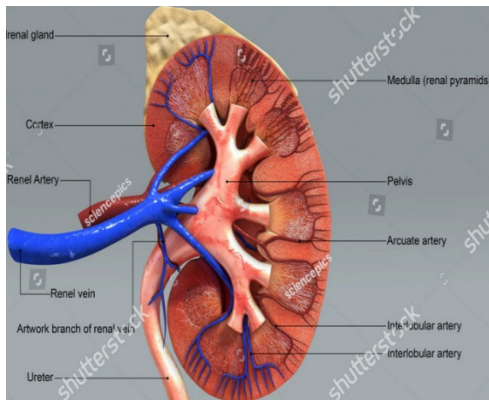
Se encuentra irrigado anteriormente por la Arteria Renal de manera posterior con la rama posterior que medialmente se prolonga hasta los vasos pre vertebrales, gonadal, ilíaca común, vesical y uterina.

INERVACIÓN



Recibe innervación parasimpática de los nervios Esplénicos Pélvicos y del plexo hipogástrico inferior.

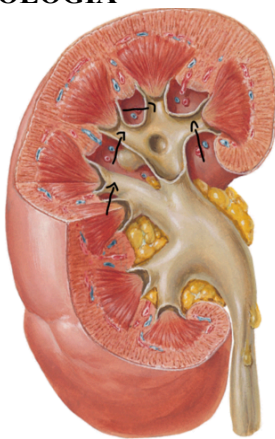
DRENAJE VENOSO



Su drenaje venoso consta de las ramas de la Vena Renal. La sangre de la pelvis renal drena hacia las venas renales, que luego desembocan en la vena cava inferior.

- Los plexos venosos de la pelvis rodean los órganos pélvicos.
- La mayoría de los plexos venosos desembocan en la vena ilíaca interna.
- La vena ilíaca interna recibe afluentes de las venas rectal media, obturatriz, sacra lateral, glútea inferior y glútea superior.

FISIOLOGÍA



Su función principal es actuar como embudo que recoge la orina producida en el riñón y la dirige hacia el uréter, desde donde se transporta a la vejiga para su almacenamiento y posterior eliminación.

- **Recogida y canalización:** La orina producida en las nefronas se recoge en los túbulos colectores y luego se drena hacia los cálices menores. Desde allí, la orina fluye hacia los cálices mayores y finalmente a la pelvis.
- **Peristalsis:** Las contracciones peristálticas del músculo liso en la pared de la pelvis renal ayudan a propulsar la orina hacia el uréter.
- **Prevención del reflujo:** La anatomía de la unión pieloureteral (donde la pelvis renal se conecta con el uréter) ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los riñones, lo cual es esencial para evitar infecciones y daño renal.
- **Adaptabilidad:** El urotelio tiene la capacidad de expandirse y contraerse, permitiendo a la pelvis manejar diferentes volúmenes de orina sin sufrir daño.



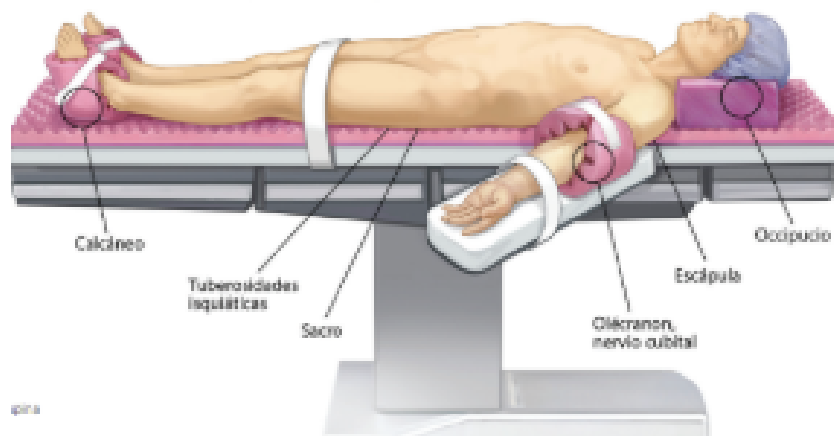
- **Protección Inmunológica:** La pelvis renal posee una mucosa que actúa como barrera defensiva contra patógenos y sustancias tóxicas presentes en la orina.

1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
• Canasta general • Cistoscopio • Canasta de nefrolitotomía percutánea • Dilatadores Amplatz • Pinza de tres garra o coágulos • Lente de nefroscopio • Litotriptor mecánico • Catéter doble J	• Torre de laparoscopia • Paquete de ropa general • Fundas de laparoscopia • Fundas de intensificador • Sábanas plásticas • Micropore • Equipo de irrigación en Y • Frasco de patología • Jeringas de 10cc y 20cc • Jeringa de 50cc punta rosca • Sonda Foley 18 y 16 de 2 vías • Equipo de macrogoteo • Cistoflo	• Piel: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm. • Seda 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja 27 mm	• Azul de metileno

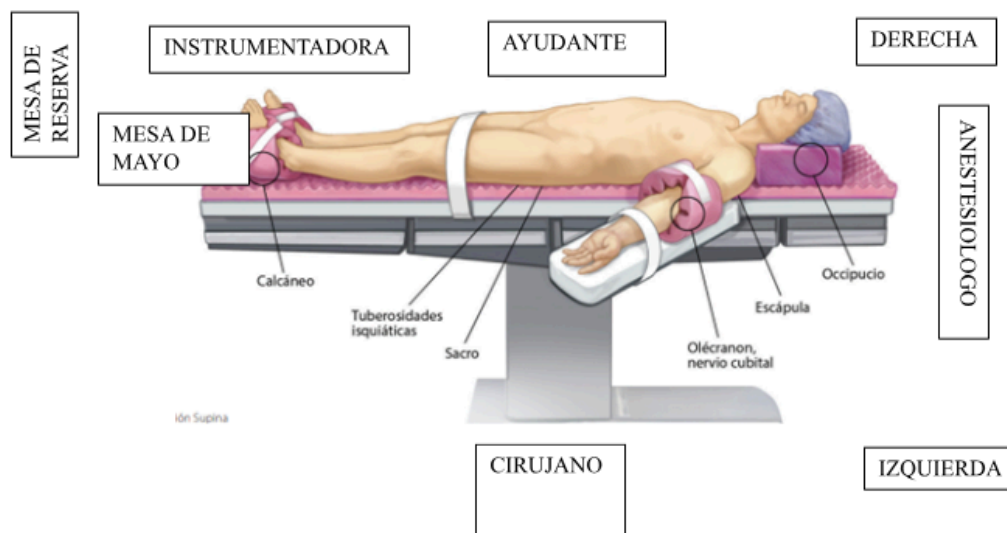


2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):



Decúbito supino o decúbito lateral. Muy rara vez de cubito prono.

2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



• **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

a) **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):**

- Anestesia General.

b) **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):**

- Se realiza una pequeña incisión cutánea



c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se hace una cistoscopia donde se va a introducir el catéter ureteral, luego se le conecta una jeringa al cistoscopio para inyectarle el medio de contraste: azul de metileno.
Punción con aguja de chiba
Se pasa la aguja sensor o hidrofílica
Se dilata utilizando dilatadores de amplatz (pasta) o alken (acero inoxidable) desde el número más pequeño hasta el número del nefroscopio. Se debe pasar un mango de bisturí número 3 con hoja #10 o #15 para ampliar la incisión de la piel y una pinza Kelly.
Introducir el nefroscopio para mirar en donde está ubicado el cálculo.
Una vez ubicado se hace uso del litotriptor mecánico: es una varilla de acero que fragmenta el cálculo; o se pasa la fibra del láser: el cual pulveriza el cálculo.
Se utiliza la pinza de coágulos o la pinza de tres garras (indicada para los cálculos) para retirar los fragmentos que quedaron del cálculo.
Una vez acabado se retira el nefroscopio. Opcional el dejar un catéter doble Jota. Se coloca un punto de seda para suturar la piel.

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES